Skolyoz Atölyesi / 14.10.2026

Üç gerçek hasta, dört klinik bölüm

60 dakikalık ders planı · 17 karar noktası

Hasta A’nın konservatif değerlendirmesi ve takibi; Hasta B’de korse sırasında artış; Hasta C’de atipik ve nörolojik bulgular. Görüntüler ve bildirilen kişisel veriler yayınlanmış gerçek kaynak örneklerindendir.

Bölüm	Hasta	Süre
Açılış	Grafi ve ders hedefi	3 dk
1. Konservatif karar	A	20 dk
2. Aynı hastanın takibi	A	12 dk
3. İlerleyen büyük eğrilik	B	13 dk
4. Atipik bulgulu hasta	C	10 dk
Kapanış	Üç hastayı karşılaştırma	2 dk

Uygulama

Her kararda okuma ve oylama, farklı gerekçelerin tartışılması ve kaynaklı açıklama sırasını izleyin. Süreler eğitim tasarımı önerisidir. Zoom anketi veya sohbetiyle oylama yapılabilir; prototip cihazlar arasında eşzamanlı değildir.

Kaynak ve eğitim içeriği ayrımı

Hasta verileri gerçek ve kaynakla sınırlıdır. Sorular ve moderasyon notları eğitim için hazırlanmıştır. Eksik yaş, muayene, kullanım veya sonuç bilgileri uydurulmamıştır. Bağımsız klinisyen incelemesi yapılmış değildir.

Web atölyesini aç · Bu PDF eğitmen içindir; cevapları ve sonraki görüntüleri içerir.

Bölüm 1 / 20 dakika

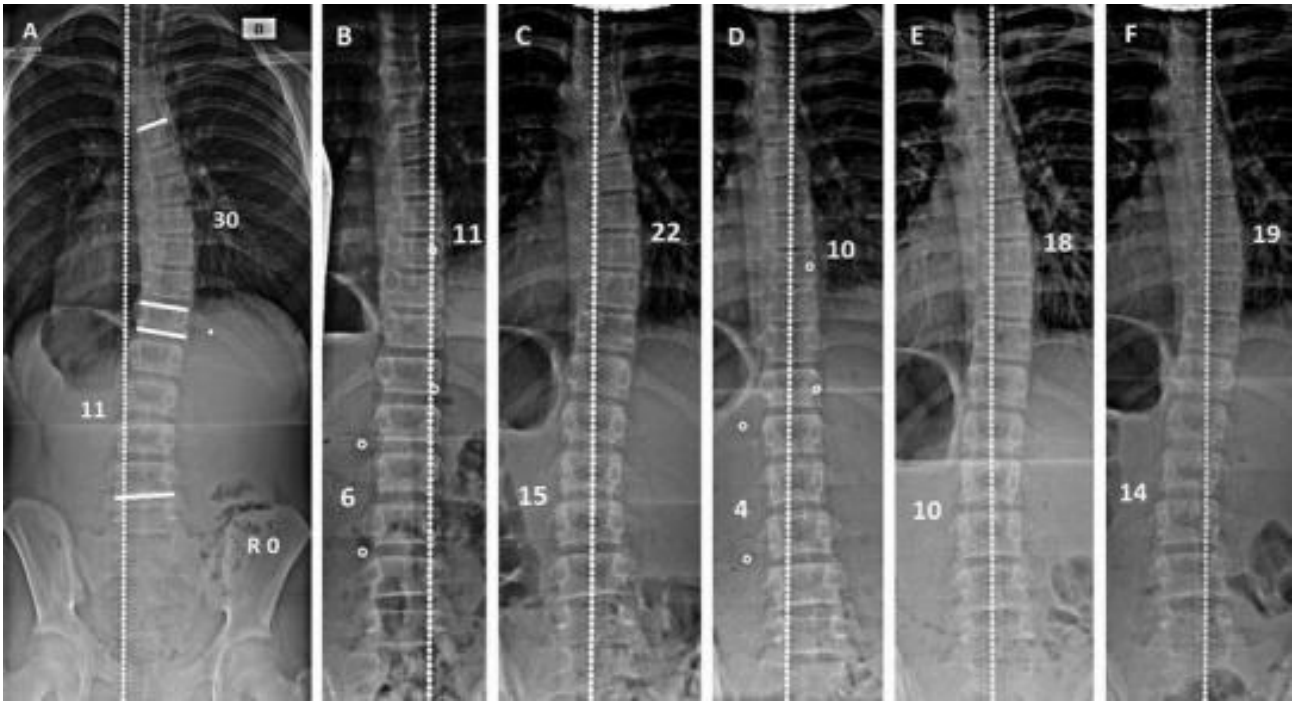
Konservatif karar

Hasta A · Başlangıçta 12 yaşında kız

Grafi, matürite ve tedavi kanıtını birleştirmek.

- Premenarşal
- Risser 0
- Kemik yaşı: 12,5 yıl
- Esnek eğrilik olarak tanımlanmış
- İlk panelde ana eğrilik 30° işaretli

Matürite bilgileri başlangıca aittir; takip evreleri verilmemiştir. Sanders, ATR, nörolojik muayene, kullanım ve PSSE ayrıntıları bu örnekte yoktur. Normal oldukları varsayılmaz.



Altı gerçek kontrol grafisi; kaynak görüntüdeki işaretler korunmuştur. Görsel düşük çözünürlüklü olduğundan hassas yeniden ölçüm yaptırılmaz. Web sayfasında başlangıçta yalnız A paneli gösterilir.

Schlenzka ve Yrjönen · Hasta A / Şekil 1

Kaynakta açık erişim; atıf: Schlenzka ve Yrjönen, 2013.

İlk grafiden güvenilir bir karşılaştırma nasıl kurarsınız?

Kaynak ilk grafide ana eğriliği 30° işaretliyor. Bu sayı bizim yeniden ölçümümüz değildir.

A. Kaynak değerini kaydeder; uç omurları, çekim koşulunu ve ileride karşılaştırılacak eğriliği belirtirim.

B. 30° sayısını kullanarak sonraki bütün grafilerin aynı koşullarda çekildiğini kabul ederim.

C. Yalnız apeks omurunu ölçer, uç omur seçimini kaydetmem.

Beklenen yaklaşım: A

Uç omur seçimi ölçüm değişkenliğinin önemli bir kaynağıdır. Kaynak açısı ile kendi ölçümünüz farklı veriler olarak kaydedilmelidir.

Seçeneklerin gerekçesi

B karşılaştırılabilirliği varsayar; C ölçüm yaklaşımını eksik bırakır.

Tartışma sorusu

Takipte farklı uç omur seçilmişse önce neyi kontrol edersiniz?

Eğitmen notu

Katılımcıdan yeni grafi istemeden önce mevcut görüntülerin ve ölçüm seçiminin nasıl inceleneceğini anlatmasını isteyin.

Gstoettner ve ark. · Cobb ölçümü

Bu matürite bilgisi hangi yorumu destekler?

Premenarşal, Risser 0 ve kemik yaşı 12,5 yıl kaynakta bildirilmiş.

A. Kesin iki yıl büyüme kaldığını ve Sanders 3 olduğunu söyleyebilirim.

B. İskelet olgunluğu tamamlanmamıştır; kalan büyümeyi ek verilerle değerlendiririm.

C. Risser 0, eğriliğin kesin ilerleyeceğini kanıtlar.

Beklenen yaklaşım: B

Risser ile Sanders arasında kesin dönüşüm yapılamaz. Matürite göstergeleri değerlendirmeyi destekler; bireysel ilerleme garantisi veya kesin süre vermez.

Seçeneklerin gerekçesi

A eksik evreyi uydurur; C risk ile kesin sonucu karıştırır.

Tartışma sorusu

Seri boy ölçümü veya el grafisi hangi kararı değiştirebilir?

Eğitmen notu

Kaynak hastaya yeni bir Sanders evresi eklemeyin. Ek bilgi ihtiyacını tartıştırın.

Minkara ve ark. · Matürite uyumsuzluğu

Başlangıçtaki yaklaşımı nasıl gerekçelendirirsiniz?

Kaynak bu hastayı esnek eğrilik ve yeterli kalan büyüme ile korseye uygun örnek olarak sunuyor.

A. Yalnız 30° sayısından korse markası ve günlük kullanım reçetesini kesin seçerim.

B. Menarş olmadığı için tüm tedavi kararlarını ertelemeyi öneririm.

C. Korse değerlendirmesini büyüme ve eğrilikle birlikte ele alır, kişisel planı tamamlarım.

Beklenen yaklaşım: C

SRS, büyümesi süren uygun eğriliklerde korse yaklaşımını destekler. Yerleşim ve kişisel değerlendirme, korse seçimini etkiler.

Seçeneklerin gerekçesi

A değerlendirmeyi reçeteyle eşitler; B kalan büyümeyi erteleme gerekçesi yapar.

Tartışma sorusu

Bu hastada hangi eksik bilgiler korse planını etkileyebilir?

Eğitmen notu

Belirli marka veya herkes için tek doz istemeyin; klinik değerlendirmeyi gerekçelendirmeye odaklanın.

SRS · Korse yaklaşımı

Bir başarılı hasta, tedavinin kanıtını nasıl etkiler?

Elimizde yayınlanmış bir hasta serisi var; sonuçları henüz açılmadı.

A. Bu hasta iyi giderse korse her benzer hastada başarı garantisi sağlar.

B. Tek örnek öğreticidir; etkinlik için karşılaştırmalı kanıtı da değerlendiririm.

C. Tek hasta örneği hiçbir eğitim değeri taşımaz.

Beklenen yaklaşım: B

BrAIST korseyi gözlemle karşılaştırdı; temel başarı ölçütü iskelet olgunluğuna 50°'ye ulaşmadan varmaktı. Tek örnek, bu karşılaştırmalı kanıtın yerine geçmez.

Seçeneklerin gerekçesi

A bireysel sonucu geneller; C görüntü üzerinden akıl yürütmenin değerini siler.

Tartışma sorusu

Klinik hedef ile araştırmanın sonlanımı aynı şey mi?

Eğitmen notu

BrAIST popülasyon koşullarını herkes için zorunlu reçete şartına çevirmeyin.

Weinstein ve ark. · BrAIST

PSSE’yi bu planda nasıl konumlandırırsınız?

Bu gerçek hastanın PSSE uygulayıp uygulamadığı kaynak şekil açıklamasında yok.

A. PSSE’yi tamamlayıcı seçenek olarak değerlendiririm; kaynak hastada yapıldığını iddia etmem.

B. İyi korse içi düzeltme elde edilirse bu hastanın mutlaka PSSE yaptığı sonucuna varırım.

C. PSSE kanıtı bütün uygun hastalarda korseyi gereksiz kılar.

Beklenen yaklaşım: A

Schroth PSSE’nin standart bakıma eklendiği randomize çalışma yarar bildirdi. Bu, her uygun hastada korse yerine yalnız egzersiz seçilmesini kanıtlamaz.

Seçeneklerin gerekçesi

B kaynakta olmayan tedaviyi atar; C çalışmanın kapsamını aşar.

Tartışma sorusu

Genel egzersiz ile skolyoza özgü egzersiz önerisini nasıl ayırırsınız?

Eğitmen notu

Ek egzersiz kararı eğitim tartışmasıdır; bu hastanın yayınlanmış tedavi ayrıntısı olarak sunulmaz.

Schreiber ve ark. · PSSE randomize çalışması

Bölüm 2 / 12 dakika

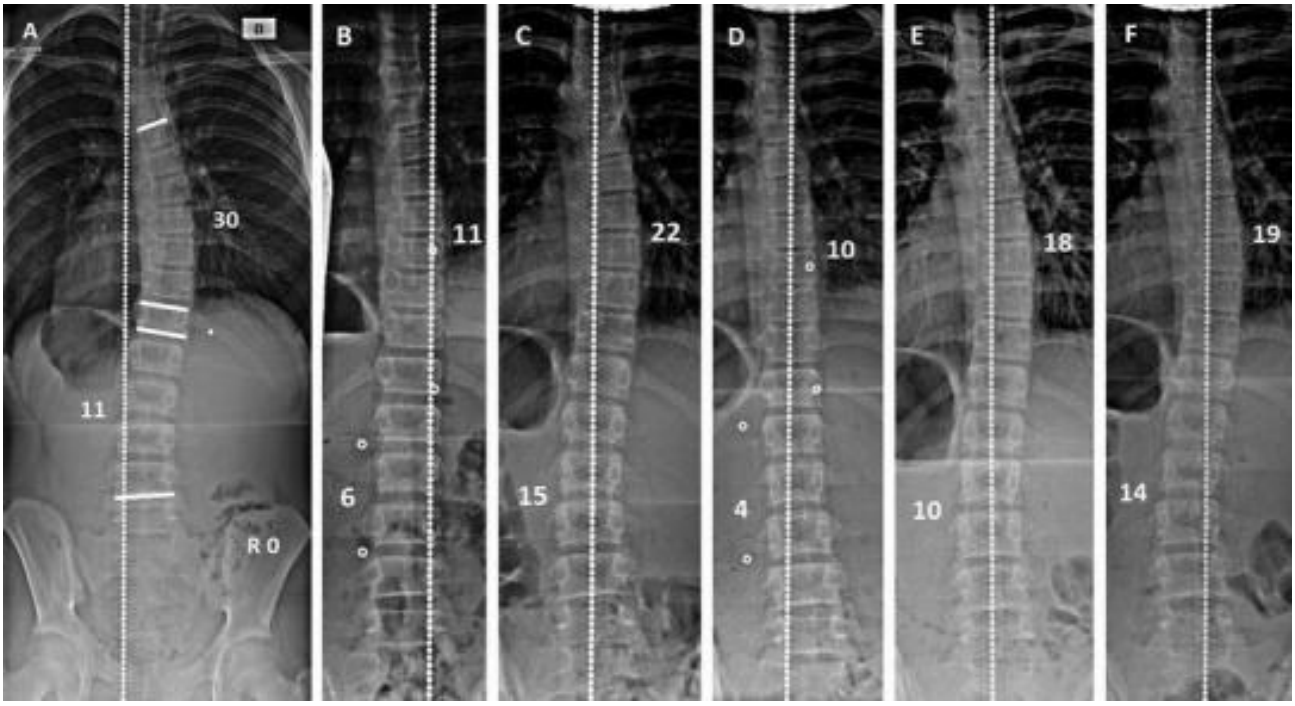
Aynı hastanın takibi

Hasta A · Başlangıçta 12 yaşında kız

Anlık korse etkisi, büyüme ve uzun dönem sonucu ayırmak.

- Premenarşal
- Risser 0
- Kemik yaşı: 12,5 yıl
- Esnek eğrilik olarak tanımlanmış
- İlk panelde ana eğrilik 30° işaretli

Matürite bilgileri başlangıca aittir; takip evreleri verilmemiştir. Sanders, ATR, nörolojik muayene, kullanım ve PSSE ayrıntıları bu örnekte yoktur. Normal oldukları varsayılmaz.



Altı gerçek kontrol grafisi; kaynak görüntüdeki işaretler korunmuştur. Görsel düşük çözünürlüklü olduğundan hassas yeniden ölçüm yaptırılmaz. Web sayfasında başlangıçta yalnız A paneli gösterilir.

Schlenzka ve Yrjönen · Hasta A / Şekil 1

Kaynakta açık erişim; atıf: Schlenzka ve Yrjönen, 2013.

Bu bölüm aynı Hasta A'nın devamıdır. Bir yıllık kontrol, yeni korse, bırakma başlangıcı ve bırakma sonrası gerçek kaynak görüntülerine geçilir.

İlk korse içi görüntü neyi gösterir?

Aynı hastanın B paneli açılıyor. Kaynak yaklaşık %64 korse içi düzeltme bildiriyor.

A. Korsenin o çekimdeki etkisini gösterir; uzun dönem sonucu tek başına kanıtlamaz.

B. Büyüme bitmiş ve tedavi tamamlanmıştır.

C. Başlangıç ve korse içi görüntü farklı hastalara aittir.

Beklenen yaklaşım: A

Anlık korse içi düzeltme ile tedavi sonundaki korse dışı sonuç ayrı değerlendirmelerdir. Yayınlanmış takip çalışması bu ayrımın önemini gösterir.

Seçeneklerin gerekçesi

B büyüme ve sonuç hakkında veri dışı yargı verir; C kaynak eşleşmesini yanlış kurar.

Tartışma sorusu

Başlangıç 30° ile B panelindeki işaretler neden doğrudan kalıcı düzeltme değildir?

Eğitmen notu

Kaynak %64 bildiriyor; küçük görüntü üzerinden yeniden hassas yüzde ölçtüğümüzü söylemeyin.

Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2

Birinci yıl kontrolünde hangi karşılaştırmayı yaparsınız?

C: bir yıl sonraki kontrol. D: aynı dönemde yeni korse içindeki görünüm. C’nin çekim koşulu şekil açıklamasında ayrıntılı belirtilmiyor.

A. Bütün panelleri korse dışıymış gibi aynı seri kabul ederim.

B. Çekim ve korse koşullarını ayrı kaydeder; C’nin belirsiz koşulunu tamamlamadan kesin karşılaştırma yapmam.

C. Yeni korse yapılması tek başına ilk tedavinin başarısız olduğunu gösterir.

Beklenen yaklaşım: B

Görüntülerin çekim koşulları yorumun parçasıdır. Korse içi ve korse dışı açılar aynı soruyu yanıtlamaz.

Seçeneklerin gerekçesi

A koşulları eşitler; C revizyonu tek başına başarısızlık sayar.

Tartışma sorusu

Büyüyen hastada korse uyumu için hangi bilgiler gerekir?

Eğitmen notu

Kaynak yeni korse bildiriyor; yapılış nedenini veya günlük kullanım süresini ayrıca vermiyor. Bunları uydurmayın.

Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2
Karol ve ark. · Kullanım danışmanlığı

İki yıl sonra bırakma kararı nasıl tartışılır?

E paneli: kaynak iki yıl sonra korse bırakmaya başlandığını bildiriyor. Bırakma anının Sanders ve Risser evreleri bu örnekte verilmemiş.

A. İki yıl geçtiği için bütün hastalar bırakmalıdır.

B. Başlangıç Risser 0 ise bırakma anında da Risser 0’dır.

C. Kaynak olayını kaydeder; bireysel matürite ve eğriliğe göre bırakma değerlendirmesini ayrı yaparım.

Beklenen yaklaşım: C

2024 randomize çalışmada uygun matüriteye ulaşmış hastalarda kademeli bırakmanın hemen bırakmaya üstünlüğü gösterilmedi. Bu sonuç, matürite değerlendirmesini gereksiz kılmaz.

Seçeneklerin gerekçesi

A zamanı tek ölçüt yapar; B matüriteyi değişmez sayar.

Tartışma sorusu

Bırakma zamanı ile bırakma yöntemi hangi iki farklı sorudur?

Eğitmen notu

Kaynağın tarihsel uygulaması bugünkü herkese uygulanacak protokol olarak sunulmaz.

Cheung ve ark. · 2024 korse bırakma RCT

Bir yıl sonraki sonucu nasıl anlatırsınız?

F: bırakmadan bir yıl sonraki kontrol. Kaynak korse dönemi boyunca 12 cm büyüme ve olumlu sonuç bildiriyor.

A. Kaynak sonucu olumlu; yine de görünüm, işlev ve hasta deneyimi gibi sonuçları ayrı değerlendiririm.

B. Bu tek grafi yaşam boyu ilerleme olmayacağını kanıtlar.

C. İyi sonuç varsa hasta kullanım güçlüğü hiç yaşamamıştır.

Beklenen yaklaşım: A

Olumlu radyografik sonuç ile hastanın kullanım deneyimi farklı veriler olabilir. Kullanım verisine dayalı danışmanlık çalışması, bu sürecin ayrıca ele alınabileceğini gösterir.

Seçeneklerin gerekçesi

B süreyi aşan garanti verir; C kaydedilmemiş deneyimi varsayar.

Tartışma sorusu

Hastanın sonucu hakkında hangi bilgiler hâlâ eksik?

Eğitmen notu

Kullanım saatleri ve yaşam kalitesi ölçümleri bu kaynak örnekte verilmedi. İleride edinilecek klinik veriler ile yayınlanmış olayı ayırın.

Karol ve ark. · Kullanım danışmanlığı

Bölüm 3 / 13 dakika

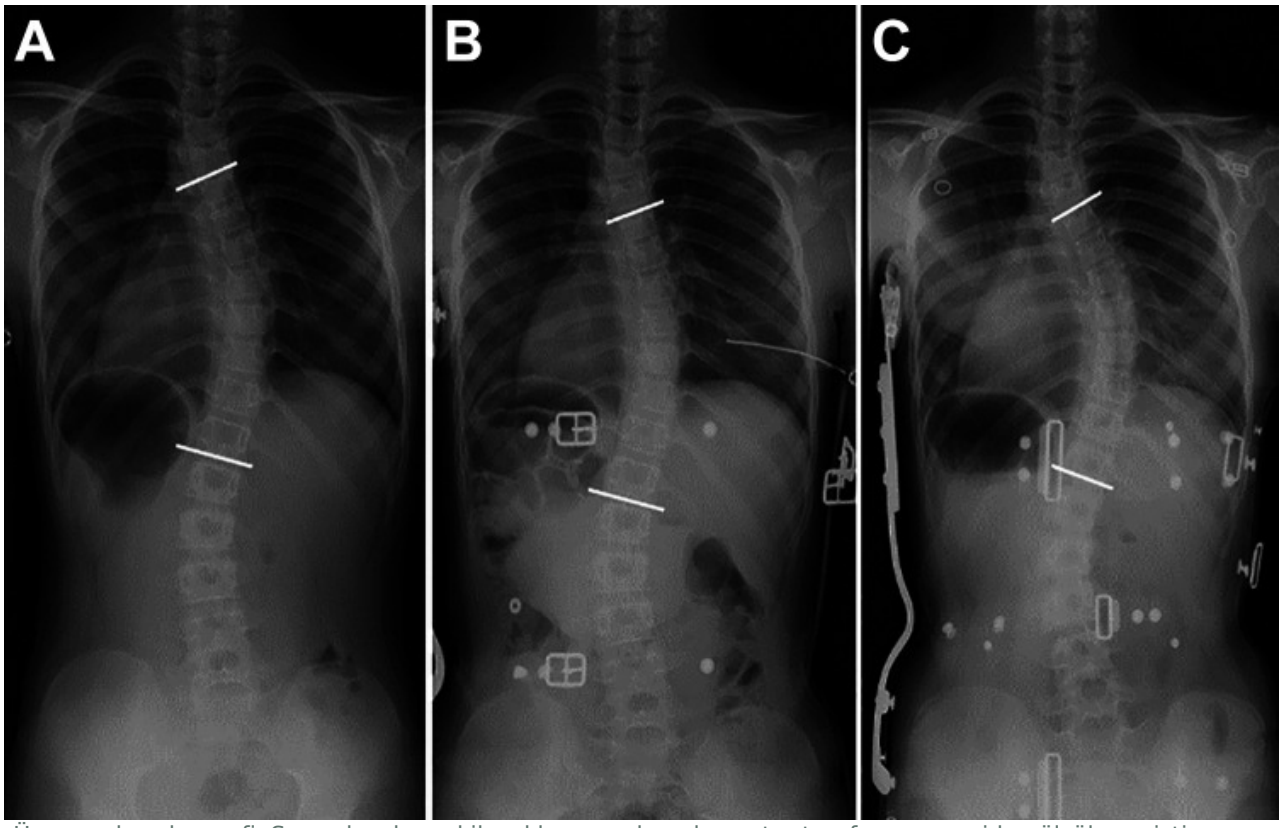
İlerleyen büyük eğrilik

Hasta B · Korse sırasında artış

Artışı doğrulamak; neden ve sevk kararını tek sayıya indirgememek.

- Kaynak ana eğrilik aralığı: T5-T12
- Korse öncesi ayakta grafi: 35°

Şekil açıklamasında hastaya özgü yaş, cinsiyet, Risser, kullanım saati ve son cerrahi sonuç verilmemiştir. Kohort ortalamaları bu hastaya atanmaz.



Üç gerçek radyografi. Sayısal açılar şekil açıklamasından alınmıştır; tarafımızca yeniden ölçülmemiştir.

Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2

Kawasaki ve ark., Global Spine Journal, 2021/2023 · CC BY-NC-ND 4.0; orijinal dosya değiştirilmedi.

Kaynakta hastanın sonradan ameliyat olduğu bildirilmemiştir. Cerrahi görüş sorusu, görüntüler üzerinden önerilen klinik akıl yürütmedir.

Bölüm 3 / Karar 1 / Ders genelinde 10-17

İkinci hastada başlangıç verisini nasıl kaydedersiniz?

Farklı kaynak hasta: ana eğrilik T5-T12, korse öncesi ayakta Cobb 35°.

A. 35°'yi ve çekim koşulunu kaydeder; bireysel matürite verisinin eksik olduğunu belirtirim.

B. Önceki hastanın Risser 0 ve yaş 12 bilgisini buraya taşırım.

C. Araştırmanın ortalama yaşını bu hastanın yaşı olarak yazarım.

Beklenen yaklaşım: A

Hastaya ait veri ile çalışma kohortunun özelliği farklıdır. Şekil açıklamasında olmayan bireysel değerler atanmaz.

Seçeneklerin gerekçesi

B ve C kaynak hastayı başka verilerle birleştirir.

Tartışma sorusu

Bu eksiklik klinik kararın hangi kısmını sınırlar?

Eğitmen notu

Tanı kartı tam hasta dosyası değildir; görsel kaynak örneğiyle sınırlıdır.

Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2

Bölüm 3 / Karar 2 / Ders genelinde 11-17

İlk korse içi yanıtı nasıl hesaplayıp yorumlarsınız?

B paneli açılıyor: başlangıç 35°, ilk korse içi 29°.

A. Yaklaşık %17 korse içi düzeltme; bu anlık yanıtı uzun dönem sonuçtan ayırırım.

B. 6° azalma olduğu için %6 düzeltme vardır.

C. Herhangi bir azalma cerrahi riskinin sıfırlandığını gösterir.

Beklenen yaklaşım: A

Verilen sayılardan (35−29)/35 × 100 ≈ %17 hesaplanır. Bu matematiksel oran, tek başına tedavinin nihai başarısı değildir.

Seçeneklerin gerekçesi

B derece ile yüzdeyi karıştırır; C garanti verir.

Tartışma sorusu

Bu hastaya özel yeterlilik için hangi bilgiler gerekir?

Eğitmen notu

Günlük gerçek kullanım, uyum, esneklik ve matürite verileri sağlanmadan yalnız yüzdeden kesin neden veya son reçete çıkarmayın.

Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2

Sonraki korse içi görüntü neyi değiştirir?

C paneli: sonraki korse içi Cobb 44° olarak bildirilmiş.

A. 35° korse dışı ile 44° korse içini koşullarını belirtmeden tek seri yaparım.

B. 29° ve 44° korse içi bulguları dikkate alır; ölçüm, korse ve kullanım değerlendirmesini yenilerim.

C. Artışın kesin nedeni hastanın korsesini takmamasıdır.

Beklenen yaklaşım: B

Kaynak korse içi artış örneği bildiriyor. Görsel tek başına kullanım saatini veya artışın nedenini belirlemez.

Seçeneklerin gerekçesi

A koşulları atlar; C kaynağa nedensellik ekler.

Tartışma sorusu

Hangi veri kullanım sorunu ile korse uyumunu ayırmanıza yardımcı olur?

Eğitmen notu

Kaynakta bulunmayan sensör çizelgesi, süre veya uyumsuzluk öyküsü üretmeyin.

Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2
Karol ve ark. · Kullanım danışmanlığı

Cerrahi görüşü bu aşamada nasıl çerçevelersiniz?

Artış gösteren korse içi 44° var. Güncel korse dışı grafi ve bireysel matürite henüz verilmemiş.

A. 44° olduğu için otomatik ameliyat kararı veririm.

B. 45° altında olduğu için tüm değerlendirmeyi ertelerim.

C. Omurga ekibi değerlendirmesini tartışır; korse dışı büyüklük, matürite, gidiş ve hasta hedefleriyle planı tamamlarım.

Beklenen yaklaşım: C

SRS cerrahiyi genellikle 45°–50° üzeri eğrilikler ve ilerleme riski bağlamında ele alır. Görüş istemek ile ameliyat kararı aynı değildir.

Seçeneklerin gerekçesi

A eksik dosyayı tek sayıyla kapatır; B ilerleyen tabloyu görmezden gelir.

Tartışma sorusu

Hastaya sevk gerekçesini nasıl söylersiniz?

Eğitmen notu

Bu kaynak hastanın cerrahiye gidip gitmediği şekil açıklamasında yok. Önerilen değerlendirme, eğitimdeki klinik akıl yürütmedir.

SRS · Cerrahi değerlendirme

Bölüm 4 / 10 dakika

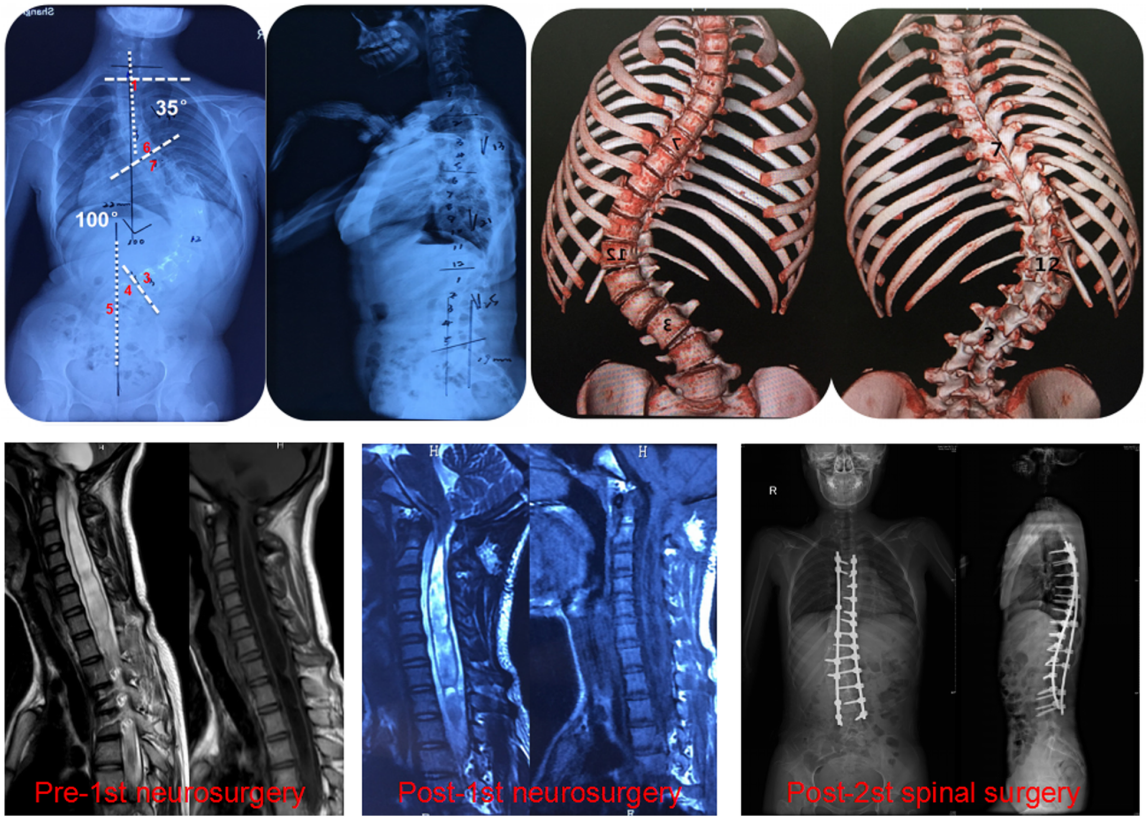
Atipik bulgulu hasta

Hasta C · 13 yaşında kız

Nörolojik bulgularla idiyopatik varsayımını yeniden değerlendirmek.

- Omurga deformitesi öyküsü: 1 yıl
- Kaynak: 38 kg, 138 cm
- T1-T6: 35°; T7-L3: 100°
- Kaynak Risser ifadesi: 0-I

Kaynağın “0-I” ifadesini kesin tek evreye çevirmiyoruz. Menarş, Sanders ve günlük korse kullanımı bu hasta için verilmemiştir.



Aynı kaynak hastanın radyografi, 3D rekonstrüksiyon, MRG ve tedavi sonrası görüntülerini içeren gerçek şekil. Aşamaya göre ilgili bölge gösterilir.

Xu ve ark. · Hasta C / Şekil 3

Xu ve ark., BMC Musculoskeletal Disorders, 2020 · CC BY 4.0; görüntü içeriği değiştirilmedi.

MRG ve tedavi sonuçlarını ilk soruda göstermeyin. Aşamalı bilgi açılması eğitim düzenidir; kaynakta olmayan yeni klinik olaylar yaratılmaz.

Bölüm 4 / Karar 1 / Ders genelinde 14-17

Üçüncü hastada ilk varsayımı nasıl kurarsınız?

Gerçek kaynak hasta: 13 yaş kız; bir yıldır deformite. Kaynak T1-T6 için 35°, T7-L3 için 100° bildiriyor.

A. Yaş ve skolyoz görünümü nedeniyle nedeni kesin idiyopatik kabul ederim.

B. Büyük eğriliği ve paterni değerlendirir; ayrıntılı nörolojik muayene ile neden araştırmasını sürdürürüm.

C. Önceki hastanın korse süresini bu hastaya uygularım.

Beklenen yaklaşım: B

İlk görünüm, etiyolojik değerlendirmeyi tamamlamaz. Yüksek riskli çocuklarda nöroaksiyel değerlendirme seçici görüntülemeyle desteklenebilir.

Seçeneklerin gerekçesi

A tanıyı erken kapatır; C farklı hastaları birleştirir.

Tartışma sorusu

Radyografide görülmeyen hangi muayene verileri önemlidir?

Eğitmen notu

MRG sonucu sonraki aşamada açılır. İlk kararı sonuç bilgisi olmadan tartışın.

ACR · Scoliosis-Child

Yeni nörolojik bulgular önceliği nasıl değiştirir?

Kaynak anormal abdominal refleks, parestezi ve ayak bileği klonusu bildiriyor.

A. Etiyolojik ve nöroaksiyel incelemeyi önceliklendiririm.

B. Bulguları eğriliğin büyüklüğüne bağlayıp incelemeden geçerim.

C. Yalnız Risser evresini yeniden hesaplamak yeterlidir.

Beklenen yaklaşım: A

Bu bulgular idiyopatik varsayımını yeniden değerlendirmeyi gerektirir. ACR, risk faktörleri olan adolesanlarda MRG'nin seçici kullanımını destekler.

Seçeneklerin gerekçesi

B nörolojik bulguları açıklanmadan normalleştirir; C sorunun kapsamını daraltır.

Tartışma sorusu

Muayene bulgusu ile bir MRG tanısı arasında nasıl bir ayrım var?

Eğitmen notu

Anormal refleks, tek başına belirli bir patolojinin kesin tanısı değildir.

ACR · Scoliosis-Child

Bölüm 4 / Karar 3 / Ders genelinde 16-17

MRG bilgisi tanı çerçevesini nasıl değiştirir?

Gerçek kaynak MRG sonucu açılıyor: Chiari malformasyonu ve siringomiyeli.

A. Bu bulguları rutin idiyopatik olguya ek bir görüntü ayrıntısı sayarım.

B. Tek başıma cerrahi tekniği ve zamanını kesin belirlerim.

C. Nöroaksiyel patolojiyi plana dahil eder; omurga ve nöroşirürji ekipleriyle değerlendirmeyi koordine ederim.

Beklenen yaklaşım: C

Bulgular klinik değerlendirme kapsamını değiştirir. Kişiye özgü cerrahi sıra ve zaman için ekip değerlendirmesi gerekir.

Seçeneklerin gerekçesi

A yeni tanıyı etkisiz sayar; B eldeki dosyanın ve eğitim rolünün sınırını aşar.

Tartışma sorusu

Hastanın hangi yeni tanı bilgileri tedavi konuşmasını değiştiriyor?

Eğitmen notu

Görüntü doğrudan kaynak hastaya aittir. Başka hastanın MRG’siyle eşleştirme yapılmadı.

Xu ve ark. · Hasta C / Şekil 3

Yayınlanmış tedavi sırasını nasıl yorumlarsınız?

Kaynak bu hastada önce posterior fossa dekompresyonu, ardından T4-L4 skolyoz cerrahisi bildiriyor.

A. Bütün Chiari ve skolyoz hastaları için aynı sıra ve süre zorunludur.

B. Bu hastanın gerçek tedavi sırasını öğrenirim; tüm hastalara değişmez protokol olarak genellemem.

C. İlk girişim sonrası mutlaka bütün eğrilik tamamen kaybolmalıdır.

Beklenen yaklaşım: B

Bu, kaynak hastanın bildirilen yönetimidir. Bir örneğin sırası veya sonucu bütün hastaların aynı yönetimi gerektirdiğini göstermez.

Seçeneklerin gerekçesi

A örneği zorunlu kurala çevirir; C kaynakta olmayan sonuç garantisi verir.

Tartışma sorusu

A, B ve C hastalarında kararın temelini değiştiren farklar nelerdir?

Eğitmen notu

Son bölümde üç hastayı karşılaştırın: büyüme ve konservatif plan; korse sırasında artış; nöroaksiyel patoloji.

Xu ve ark. · Hasta C / Şekil 3

Kaynak haritası

Gerçek vakalar ve klinik kanıtlar

Schlenzka ve Yrjönen · Hasta A / Şekil 1

https://journals.sagepub.com/doi/10.1007/s11832-012-0464-5

Kawasaki ve ark. · Hasta B / Şekil 2

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21925682211032559

Xu ve ark. · Hasta C / Şekil 3

https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-020-3182-z

Gstoettner ve ark. · Cobb ölçümü

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17549526/

Minkara ve ark. · Matürite uyumsuzluğu

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31923164/

SRS · Korse yaklaşımı

https://www.srs.org/Patients/Diagnosis-And-Treatment/Bracing

Weinstein ve ark. · BrAIST

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3913566/

Schreiber ve ark. · PSSE randomize çalışması

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168746

Karol ve ark. · Kullanım danışmanlığı

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26738898/

Cheung ve ark. · 2024 korse bırakma RCT

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38829664/

SRS · Cerrahi değerlendirme

https://www.srs.org/Patients/Diagnosis-And-Treatment/Surgery

ACR · Scoliosis-Child

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31054751/

SOSORT 2016 · Klinik kılavuz

https://doi.org/10.1186/s13013-017-0145-8

Gerçek örnekler farklı tarihlerden gelir. Eski makalelerin tarihsel tedavi yorumları, daha yeni kanıtlar değerlendirilmeden güncel klinik öneri olarak sunulmaz. Araştırma katılım kriterleri zorunlu reçete şartı değildir.

Kaynak bilgilerinin aşamalı sunumu öğretim düzenidir. Öğrenci yanıtlarının farklı olması için gerçek hastanın sonucu değiştirilmez. Bu PDF’de tam kaynak şekilleri; web sayfasında ilgili panellerin ekran görünümü kullanılır.